Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5115864-02.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: PEDRO ADEMAR RAMOS

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

PEDRO ADEMAR RAMOS ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **câncer de pulmão de pequenas células (CID10-C34.9)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Durvalumabe 500mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 22, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 35, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 32, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 37, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 45, DESPADEC1), nada requereram (evento 48, PET1; evento 51, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 54, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 22, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de Câncer de Pulmão de Pequenas Células (CID10 - C34.9), necessitando fazer uso do medicamento Durvalumabe 500mg. Ressaltou a urgência do tratamento indicado que "consiste em quimioterapia baseada em platina, associada a imunoterapia, conforme referência em anexo. Este último, não está contemplado nas novas diretrizes do IPE. Não há outra alternativa similar no protocolo do IPE" (evento 15, LAUDO2):*
>
> *[...]*
>
> *A nota técnica, por sua vez, sobreveio com conclusão favorável ao tratamento requerido (evento 20, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do IPE-SAÚDE (evento 1, OUT6).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*
>
> *Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.*

Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPE-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Durvalumabe 500mg**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 15, LAUDO2), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **câncer de pulmão de pequenas células (CID10-C34.9)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Durvalumabe 500mg**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento. Senão vejamos:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

Receituário Médico

PACIENTE
PEDRO ADEMAR RAMOS
CPF: 273.286.430-72

JUSTIFICATIVA DE TRATAMENTO:

Atesto, para fins de comprovação, que o paciente PEDRO ADEMAR RAMOS, é portador de neoplasia maligna classificada sob CID-10 C34.9 (Câncer de pulmão de pequenas células), diagnosticada em 22/03/2024 quando paciente apresentou cefaleia não controlável com analgesia via oral. Ao chegar à emergência, paciente identificou múltiplos implantes em sistema nervoso central. Um destes causava herniação cerebral (transcrevo laudo abaixo). Assim, paciente foi submetido a ressecção da lesão cerebral, dada a urgência do quadro.

Ressonância de crânio de 22/03/2024: Múltiplas lesões expansivas no parênquima encefálico tanto supratentorial quanto infratentorial determinando efeito de massa com redução da amplitude das cisternas ponto-cerebelares, bem como do IV ventrículo e herniação tonsilar através do forame magno em aproximadamente 0,5 cm. Estas lesões mais provavelmente estão relacionadas a acometimento neoplásico secundário.

A lesão retirada durante cirurgia confirmou câncer de pulmão de pequenas células. Neste contexto, o tratamento indicado consiste em quimioterapia baseada em platina, associada a imunoterapia, conforme referência em anexo. Este último, não está contemplado nas novas diretrizes do IPE. Não há outra alternativa similar no protocolo do IPE.

Referência:
1. Machiyama H, Minami S. Durvalumab for Extensive-Stage of Small-Cell Lung Cancer With Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. J Med Cases. 2023 Feb;14(2):71-75. doi: 10.14740/jmc4043. Epub 2023 Feb 25. PMID: 36896371; PMCID: PMC9990708.

17 de Junho de 2024

PRISCILA SILVA CRM-RS 41570
Oncologia Clínica (RQE: 39833), Clínica Médica (RQE: 39059)
Endereço Comercial: RUA LUIZ DE CAMÕES, 900 604 BL B, SANTO ANTONIO, PORTO ALEGRE - RS
Telefone: (51) 3922-1619

Receituário emitido no dia 17/06/2024 11:04:49 por PRISCILA SILVA - 41570/RS para PEDRO ADEMAR RAMOS (CPF: 273.286.430-72 carina_mr3@hotmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/receita/idCcVxtd** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Este documento foi emitido e assinado eletronicamente por PRISCILA SILVA 41570/RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 17/06/2024 11:04:49.

Ainda, o laudo médico atualizado indica que o paciente apresentou boa resposta ao uso da medicação pleiteada e que é necessária a manutenção do tratamento (evento 57, LAUDO2):

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

1ª Via Farmácia
2ª Via Paciente

Receituário Médico Controle Especial

PACIENTE

PEDRO ADEMAR RAMOS — CPF: 273.286.430-72

Endereço: ALAMEDA VICENTE DE CARVALHO — Bairro: BOA VISTA

Município/UF: PORTO ALEGRE/RS — CEP: 91340490

PRESCRIÇÃO

Laudo médico de atualização do quadro oncológico:

Atesto, para fins de comprovação, que Pedro Ademar Ramos diagnosticou neoplasia maligna de CID-10 C34.9 em estádio IV em abril de 2024. Paciente realizou ressecção de lesão em sistema nervoso central, seguida por quimioterapia e radioterapia. Paciente apresentou resposta ao tratamento e então iniciou manutenção com imunoterapia. Paciente vem mantendo resposta ao tratamento, conforme visto em exames de imagem.

02 de Dezembro de 2024

PRISCILA SILVA CRM-RS 41570

Oncologia Clínica (RQE: 39833), Clínica Médica (RQE: 39059)

Endereço Comercial: RUA LUIZ DE CAMÕES, 900 604 BL B, SANTO ANTONIO, PORTO ALEGRE - RS

Telefone: (51) 3922-1619

ICP Brasil

Receituário emitido no dia 02/12/2024 13:17:34 por PRISCILA SILVA - 41570/RS para PEDRO ADEMAR RAMOS (CPF: 273.286.430-72 carina_mr3@hotmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/receita/X6j4Z6pM** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por PRISCILA SILVA 41570/RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 02/12/2024 13:17:34.

Com efeito, a médica assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pela médica assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º*

da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2. ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por PEDRO ADEMAR RAMOS em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Durvalumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 12/05/2025, às 18:54:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082273210v5** e o código CRC **703ad60e**.